

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Vermilionectomy

معلومات الإقرار – نسخة المريض استئصال حافة الشفة

1. What do I need to know about this procedure?

A vermilionectomy is a procedure where all or part of the visible lower 'red' lip will be removed. This will leave an open wound. This wound will be closed by moving the inside of the lower lip. This is sewn to the skin below the "red" lip to make a new lower lip.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the

1-ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟

في إجراء استئصال حافة الشفة تتم إزالة كل أو جزء من جزء الشفة المرئي ذو اللون الأحمر. يترك ذلك جرحاً مفتوحاً. يتم إغلاق هذا الجرح بتحريك الجزء الداخلي للشفة السفلية. يتم خياطة ذلك مع الجلد الموجود أسفل المنطقة الحمراء من الشفة لخلق شفة سفلية جديدة.

2-التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. **اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه.** إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات، قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في طلبها.

3-ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات، وهي تشمل، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

strain on the heart.

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The surgery to close the skin may fail. This may cause bad scarring, and you may need further surgery.
- Blood and fluid may build up under the new red lip, which may need removal.
- The lip will not look like a normal lip with stitches in place. The colour changes between days 1 to 5. Once the stitches are removed, the lower lip will not look like a normal lip for some time. In extreme cases, the lip may never look normal.
- A scar at the border between the red lip and the skin below the lip. The scar may become very thick, red, itchy and thickened. These are difficult to treat and can be disfiguring.
- A collection of blood in the tissues due to unwanted bleeding. If this occurs it increases the appearance of bruising. Swelling can lead to slow healing or a failure to heal.
- Infection which can lead to poor healing of the wound. This may require antibiotics and further treatment.
- The new lip tissue covering the wound may die. This may cause a larger scar or may need further surgery.
- The diseased tissue may not all be removed at surgery. This may need further surgery and removal of a wider piece of tissue.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis. Smoking before or after surgery can also cause complications ranging from excessive bleeding and bruising to major wound breakdown.

أو سكتة دماغية.

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد تفشل جراحة إغلاق الجلد . قد يؤدي ذلك إلى نشوء ندب سيئ وقد يتطلب الأمر جراحة أخرى.
- قد يحدث تراكم للدم والسوائل تحت الشفة الحمراء الجديدة . قد يتطلب الأمر إزالة هذه التجمعات.
- لن تظهر الشفة كأي شفة طبيعية في وجود الغرز الجراحية. يتغير اللون في غضون 1-5 أيام. بمجرد إزالة الغرز ، لا تظهر الشفة السفلية بشكل طبيعي لبعض الوقت. في أسوأ الحالات ، قد لا يكون مظهر الشفة طبيعياً إلى الأبد.
- وجود ندب في منطقة الحدود بين الشفة الحمراء والجلد أسفلها. قد يصبح الندب شديد السماكة ، أحمر اللون ، يكون سميكاً ومسبباً للحكة. من الصعب علاج ذلك ، وقد يتسبب في حدوث تشوه.
- تجمع السوائل في الأنسجة بسبب نزيف غير مرغوب فيه . عند حدوث ذلك فإنه يزيد من ظهور الكدمة. التورم قد يؤدي إلى تأخر الالتئام أو عدم حدوث الالتئام.
- حدوث عدوى مما يسبب ضعف التئام الجرح ، مما قد يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- قد يموت نسيج الشفة الجديدة الذي يغطي الجرح. قد يؤدي ذلك إلى حدوث ندب أكبر أو قد يتطلب جراحة أخرى.
- قد لا تتم الإزالة الكاملة للنسيج المريض خلال الجراحة. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى وإزالة لمساحة أوسع من النسيج.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية. قد يسبب التدخين قبل أو بعد الجراحة أيضاً مضاعفات تتراوح ما بين النزيف المفرط وحدوث كدمة إلى تهتك وانفصال شديد في جوانب الجرح.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Notes to talk to my doctor about:

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
